

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA AUTOAPLICADA DE ADAPTACIÓN SOCIAL (SASS)

Eje IV: Funcionamiento y Ajuste Social • Medida Específica del Comportamiento Social en Depresión

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala Autoaplicada de Adaptación Social (SASS).
Nombre Original	Social Adaptation Self-evaluation Scale (SASS; Bosc, Dubini & Polin, 1997).
Autores Originales	Michel Bosc, M.D., A. Dubini, M.D. y V. Polin, M.D. (Francia / Suiza).
Adaptación Hispana	Bobes, González, Bousoño et al. (1999); Universidad de Oviedo / CIBERSAM.
Eje Clínico y Constructo	Eje IV: Ajuste y Funcionamiento Social. Motivación, conducta y conexión interpersonal.
Tipo de Instrumento	Cuestionario de autoinforme estructurado (21 reactivos con bifurcación laboral).
Formato de Respuesta	Escala Likert graduada de 4 puntos (0 = peor ajuste a 3 = óptima adaptación).
Población y Rango	Adultos (≥ 18 años) con trastornos del estado de ánimo (depresión, distimia, bipolaridad).
Tiempo de Administración	8 a 12 minutos de cumplimentación autónoma.
Régimen de Licencia	Acceso abierto para práctica clínica y ensayos terapéuticos bajo citación formal.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL AJUSTE SOCIAL ACTIVO EN LA RECUPERACIÓN

La **SASS** fue concebida por Bosc y colaboradores (1997) para subsanar un vacío en la psicopatología de la depresión:

- Más Allá del Alivio de Síntomas:** La remisión sintomática estricta (bajada del afecto disfórico o de ideas suicidas) no equivale a la **reincorporación psicosocial activa**. Numerosos pacientes conservan una desadaptación pasiva caracterizada por retraimiento, evitación social y pérdida de motivación.
- Exploración de la Conducta Social Manifiesta:** Evalúa conductas concretas de interacción: iniciar conversaciones, expresar opiniones, buscar ocio gregario, interesarse por el prójimo y disfrutar del trabajo u obligaciones domésticas.
- Sensibilidad Diferencial Antidepresiva:** La SASS demostró una capacidad única para discriminar fármacos con acción noradrenérgica/dopaminérgica (que impulsan la motivación y el empuje social) frente a agentes puramente serotoninérgicos.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE REACTIVOS (21 ÍTEMS)

Área Funcional	Ítems SASS	Contenido y Criterios Evaluados
1. Trabajo / Ocupación	Ítem 1 o Ítem 2	Ítem 1 (empleados): interés y satisfacción laboral; Ítem 2 (hogar/jubilados): tareas del hogar.
2. Interés y Motivación	Ítems 3 al 6	Curiosidad por el entorno, entusiasmo por proyectos, ganas de informarse.
3. Vínculos Familiares	Ítems 7 al 10	Calidez en el trato con parientes cercanos, búsqueda de compañía familiar.
4. Vida Social Externa	Ítems 11 al 15	Relaciones con amigos, participación en reuniones, facilidad para entablar contacto.
5. Ocio y Tiempo Libre	Ítems 16 al 18	Disfrute de pasatiempos, actividades fuera del hogar, lectura o aficiones culturales.
6. Autoexpresión y Control	Ítems 19 al 21	Capacidad para defender convicciones, expresar desacuerdos y control personal.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO PSICOMÉTRICO EN ESPAÑA / LATAM

La validación española de Bobes et al. (1999; $N = 275$ pacientes con depresión mayor y controles sanos) reporta excelentes índices psicométricos:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Consistencia Interna Total	Alfa de Cronbach = 0.88 - 0.91	Excelente cohesión de la escala evaluando ajuste social multidimensional.
Estabilidad Test-Retest	CCI = 0.83 - 0.87	Alta reproducibilidad temporal a 2 semanas en sujetos clínicamente estables.
Sensibilidad Terapéutica	Tamaño efecto $d = 0.85$	Marcada capacidad discriminante de la respuesta antidepresiva a 8 semanas.
Validez Convergente Negativa	$r = -0.65$ (HAM-D)	Correlación inversa esperada con la gravedad de la melancolía y el desánimo.
Validez Concurrente	$r = 0.72$ (SF-36 FS)	Fuerte asociación directa con la subescala de Función Social del SF-36.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

• **Bifurcación Laboral Inicial:** El sujeto responde al **Ítem 1** (si realiza trabajo remunerado) o al **Ítem 2** (si realiza tareas domésticas no remuneradas, está desempleado o jubilado). Nunca se computan ambos reactivos simultáneamente. • **Escala de Respuesta:** 4 alternativas ordinales graduadas de 0 a 3 puntos (0 = nulo interés o aislamiento extremo; 3 = alto disfrute y proactividad adaptativa). • **Puntuación Total SASS (20 Reactivos Computables):** Se suman los 20 reactivos cumplimentados:

$$\text{Puntuación Total SASS} = \sum_{i=1}^{20} \text{Ítem}_i \quad (\text{Rango: 0 a 60 puntos})$$

• **Direccionalidad Clínica:** A mayor puntuación, **MEJOR adaptación social** y mayor grado de implicación conductual en el entorno.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN SOCIAL

Estratificación	Rango SASS	Percentil Poblacional	Significación Clínica y Ajuste Psicosocial
Adaptación Normal	35 a 60 pts	P50 - P99	Funcionamiento adaptativo comunitario pleno; media poblacional = 42-45 pts.
Desajuste Moderado	25 a 34 pts	P20 - P49	Dificultades en relaciones externas; pasividad social; alerta de cronificación.
Desadaptación Severa	< 25 pts	< P20	Aislamiento social crítico; colapso de motivación; deterioro interpersonal severo.

PUNTO DE CORTE CLÍNICO DE NORMALIZACIÓN SOCIAL (SASS ≥ 35):

En la validación española (Bobes et al., 1999), una puntuación de **35 puntos** demostró una sensibilidad del 82% y una especificidad del 80% para discriminar sujetos con buen ajuste social de aquellos con deterioro psicosocial clínicamente significativo. Puntuaciones < 25 definen el perfil de desadaptación severa en depresión mayor.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE REHABILITACIÓN SOCIAL Y SEGUIMIENTO TERAPÉUTICO

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN CON SASS EN DEPRESIÓN:

- **Paso 1 (Línea Base en Consulta Ambulatoria):** Administrar en la evaluación inicial del episodio disfórico (habitualmente SASS < 25).
- **Paso 2 (Evaluación a las 6 Semanas de Tratamiento):** - SASS *permanece* < 30: A pesar de mejoría anímica, existe “cura sintomática sin recuperación social”. Añadir entrenamiento en asertividad y prescripción estructurada de actividades sociales. - SASS *entre 35 y 45*: Evolución favorable; consolidar red de apoyo informal.
- **Paso 3 (Monitorización de Fármacos Activadores):** En pacientes con apatía residual refractaria, valorar adición de agentes dopaminérgicos/noradrenérgicos (Bupropión, Reboxetina).
- **Paso 4 (Mantenimiento de Alta):** Mantener puntuaciones ≥ 40 por 6 meses antes de considerar remisión funcional completa.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: RECUPERACIÓN DEL ROL COMUNITARIO TRAS DEPRESIÓN MAYOR

Identificación: Varón de 52 años, director administrativo de empresa, en remisión sintomática de un segundo episodio depresivo mayor tratado con Escitalopram 20 mg/día (HAM-D = 6). Sin embargo, rechaza invitaciones de amigos, no participa en comidas familiares y trabaja con desinterés mecánico.

Evaluación Inicial con SASS:

• **Puntuación Total SASS = 21 / 60 puntos (Desadaptación Social Severa, Percentil 12).**

• **Áreas comprometidas:** Ocio y tiempo libre = 2/9; Vida social externa = 3/15; Trabajo = 2/3 (cumplimiento formal sin iniciativa); Interés general = 3/12.

Intervención Psicosocial: Programa de Activación Conductual Social estructurada: asignación gradual de interacciones cara a cara, inscripción en club de senderismo los sábados y sesiones de rol-playing para toma de palabra en comités laborales.

Reevaluación a las 14 Semanas: La puntuación SASS ascendió a **44 / 60 puntos (Rango de Normalidad Adaptativa, Percentil 65)**. El paciente retomó el liderazgo de proyectos de equipo, volvió a organizar reuniones con amistades y verbalizó un retorno pleno a su identidad social previa.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

SOLEDAD VS. FOBIA SOCIAL: Puntajes bajos en SASS deben cotejarse: si el aislamiento se debe a ansiedad social premórbida con terror a la evaluación, tratar la fobia subyacente y no solo la depresión.

FALSA NORMALIDAD PASIVA: En sujetos con soporte familiar hiperprotector, las preguntas de convivencia pueden sobrestimar la puntuación; verificar siempre la iniciativa social autónoma fuera de la familia.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Bosc, M., Dubini, A., & Polin, V. (1997). Development and validation of a social functioning scale, the Social Adaptation Self-evaluation Scale. *European Neuropsychopharmacology*, 7(Suppl 1), S57-S70.
2. Bobes, J., González, M. P., Bousoño, M., et al. (1999). Propiedades psicométricas de la versión española de la Escala de Adaptación Social (SASS) en pacientes depresivos. *Actas Españolas de Psiquiatría*, 27(6), 360-366.
3. Bech, P. (2005). The Social Adaptation Self-evaluation Scale (SASS) as an outcome measure in depression: A review. *Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental*, 20(3), 193-199.
4. Mauri, M. C., et al. (2000). Social adaptation and antidepressant treatment: A comparative evaluation of reboxetine and fluoxetine using SASS. *European Neuropsychopharmacology*, 10(Suppl 3), S341.